

01/09

9h

INDICADO POR: plá José Luis.

(X) ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

LUIS GONZAGA NOGUEIRA PEIXOTO

IDADE: 52	PESO: 136	ALTURA: 175	PROFISSÃO: Autônomo - Cozinheiro
SINTOMAS: Sonolência diurna / SpO2 ↓↓ / Ronco presença de MHI edematizado			
QUEIXAS: manter o sono			
MEDICAMENTOS: Levoide / Losartana / Sildenafil / Sertralina			
manejado rotador (operado bilat) / tiroide (sem alt.) / HAS			
MÉDICO: Drª Rosângela / Drª Rosemary			
MARCAPASSO: () S (X) AN / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N			
EXERCÍCIO FÍSICO: Hidro (2x)			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S		ALMOÇO: S	LANCHE: N JANTAR: 19hs
HORA QUE DORME: 23:00		HORA QUE ACORDA: 5:30	
COCHILHO (X) S () N	DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE ronco		
TEM FILHOS: () S (X) N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N		PET NO QUARTO: () S (X) N	
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N eventualmente			
FUMO: () S (X) MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: mista		BANHEIRO/NOITE: 1X - 3X	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: IV	IAH: 24.7	SPO2: 80%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: ansiedade (há 15a)			
Despertares 78.50 efer			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Provalvefe			
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA	(S) NEUROLÓGICA	() OUTROS:	
POLISSONOGRAMA COM CPAP: (X) S () N		SPO2 CI/CPAP: 12.8	PRESSÃO NO EXAME: 84%
04/06 Avaliação			
25 Rotação			
11/06 P=9.0			
25 IAH=3.0			
M. de uso: 5:36			
Bem adaptado			
Bem adapt. porém			
Sonolento obs se			
é necessário			
4a P. fua.			
Fazer biologia			
23/06 P=10 cmH2O			
IAH=2.3			
mano=6 horas			
fuga=40/1 min			
Bem Adaptado sem queixas.			
fua			

07/07/25 P= 10 cm H₂O

IAH= 2,9 e/h

muco = 6h40

fuga = 6,3 l/min

Bem Adaptado

Silvia

28/07 P= 10 cm H₂O

25

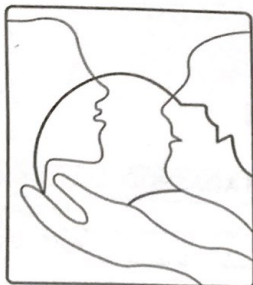
IAH= 2,3 e/h

M. de uso = 6h25'

fuga = 1,3 lpm

Oriento nutricionista / ed. físico

sua cláudia



Luiz Gonzaga Peixoto

Solicita

Dr. Bruno de Andrade Soares
Otorrinolaringologia
CRM 104.075

Dra. Celeste Aida M. Passos
Ginecologia - Obstetrícia
Ultrassonografia
CRM 39.138

Dra. Daniele de Matos S. Silva
Cirurgia Pediátrica
CRM 108.198

Dr. José Assis Murad
Cardiologia e Clínica Médica
CRM 59.703

Dr. Kleber Hirose
Cirurgia Cardiovascular
CRM 99.014

Dr. Luiz Henrique F. Moraes
Mastologia
CRM 90.979

Dr. Leonardo Inácio Marcondes Braga
Urologia / Urodinâmica
CRM 104.117

Dra. Rosemeiry Tereza Marçal
Otorrinolaringologia e Alergia
CRM 71.200

Dra. Viviane F. Ferling
Ginecologia - Obstetrícia
CRM 113.082

CPAP

4 prescrições

P com d H₂O

Dra. Rosemary T. Marçal
Otorrinolaringologia
CRM 11200

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: LUIZ GONZAGA NOGUEIRA PEIXOTO			
Sexo: M	Idade: 40 anos	Peso: 115 Kg	Altura: 1,73 m
IMC: 38,4	Data do Exame: 15/07/2012	Exame: 20016_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 23:04:20 horas e encerrado às 06:13:01 horas, com latência para o sono de 20 minutos e latência para o sono REM de 212 minutos. O tempo total de sono foi de 210,0 minutos, com eficiência do sono de 49,0%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	21,2%	Até 5%
Estágio 2	49,5%	45 - 55%
Estágio 3	16,9%	> 15%
Sono REM	12,4%	20 - 25%
Eficiência do sono	49,0%	> 85%

No período total de sono permaneceu 219,0 minutos acordado e ocorreram 49 micro despertares (índice de 14,0 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 63 bpm , a maior de 69 bpm e a menor de 58 bpm.

Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 4 eventos respiratórios, sendo 0 central, 4 obstrutivos e 0 misto. O índice de apnéia/hipopnéia total foi 1,1/hora, sendo 0,3 apnéia/hora e 0,9 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 0,0/hora, sendo 0,0 apnéia/hora e 0,0 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 94%, a maior de 97% e a mínima de 84%, permanecendo 3,2 minutos (0,7%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 30 dessaturações.

Resumo dos resultados

Exame realizado com CPAP automático, evidenciando:

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau normal (normal até 5/hora).
- 2 - Presença de dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 4 - Eficiência do sono diminuída devido ao tempo total desperto durante o exame.

Pressão sugerida de CPAP: 12,8 cmH2O

José Alexandre Addeo Cipolli
CRM-SP 104110

EXAME DE POLISSONOGRRAFIA

Nome: **Luiz Gonzaga Nogueira Peixoto**

IMC: **40,09**

Sexo: **M**

Idade: **37 anos**

Peso: **120 Kg**

Altura: **1,73 m**

Data do Exame: **15/09/2009**

Exame: **02231_01**

Médico solicitante:

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:44:57 horas e encerrado às 06:01:01 horas, com latência para o sono de 3 minutos e latência para o sono REM de 122 minutos. O tempo total de sono foi de 363 minutos, com eficiência do sono de 83,3%. A distribuição do sono mostrou 12,4% de estágio 1, 64,6% de estágio 2, 10,7% de estágios 3 e 4 e 12,3% de sono REM. No período total de sono permaneceu 73 minutos em estágio 0 e ocorreram 475 despertares breves.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 68 bpm, a maior de 107 bpm e a menor de 52 bpm. Foram identificados 0,00 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 587 eventos respiratórios, sendo 0 central, 587 obstrutivos e 0 misto. O índice de apnéia/hipopnéia total foi 97,02/hora, sendo 36,03 apnéia/hora e 60,99 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 94,38/hora, sendo 70,11 apnéia/hora e 24,27 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 97%, sendo a saturação média de 93%, a maior de 98% e a mínima de 80%, permanecendo 18 minutos (4,15%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 00:00:00 (0,00 %) minutos (0,00%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 432 dessaturações.

CONCLUSÃO

- 1- Paciente com Índice de Apnéia-Hipopnéia severo, sendo todos os eventos do tipo obstrutivo;
- 2- Dessaturações da oxihemoglobina associadas aos eventos respiratórios;
- 3- Ronco intenso;
- 4- Sono fragmentado pelo aumento do número de despertares breves (78,51/hora);
- 5- Redução da eficiência do sono devido ao tempo total desperto durante o registro;
- 6- Redução da porcentagem do sono de ondas lentas e do sono REM.

Dra Daniela Leme de Araujo
CRM 104652